

- 64★★★ ☒☒☒ 光線力学的療法 (PDT) の適応は内視鏡的に腫瘍の全範囲を確認しうることが必要である。
- 65★★★ ☒☒☒ 病的骨折の危険性の高い骨転移や、脊椎転移で脊髄が圧迫されている骨転移に対する外科治療は禁忌である。
- 66★★★ ☒☒☒ 肺癌骨転移の際に使用するデノスマブで注意すべき有害事象には、高 Ca 血症と顎骨壊死がある。
- 67★★★ ☒☒☒ 原発性肺癌に合併する髄膜癌腫症には、放射線治療が奏功する。

限局型小細胞肺癌 68 ~ 74

- 68★★★ ☒☒☒ 全例で外科的治療が優先される。
- 69★★★ ☒☒☒ 小細胞肺癌の手術症例では術後化学療法が推奨される。
- 70★★★ ☒☒☒ PS2 では化学放射線療法が推奨される。
- 71★★★ ☒☒☒ 同時化学放射線療法で推奨される加速過分割照射は、総線量 60Gy が標準である。
- 72★★★ ☒☒☒ 同時化学放射線療法で推奨されるレジメンは、プラチナ製剤+エトポシドである。
- 73★★★ ☒☒☒ PS0-1、70 歳以下の同時化学放射線療法ではプラチナ製剤+エトポシドに免疫チェックポイント阻害薬の併用を検討する。
- 74★★★ ☒☒☒ PS0-1、70 歳以下の同時化学放射線療法後に抗 PD-L1 抗体による維持療法の投与が有効である。

進展型小細胞肺癌 75 ~ 80

- 75★★★ ☒☒☒ PS2 ではプラチナ製剤併用療法に加えて抗 PD-L1 抗体の上乗せが推奨される。
- 76★★★ ☒☒☒ 間質性肺炎合併患者に対するイリノテカンの投与は禁忌である。
- 77★★★ ☒☒☒ イリノテカン投与中は、嘔吐や下痢などの消化器毒性が多くみられる。

